

TEMA 3.49 • OBSTETRICIA

Puerperio Normal

PERFIL EUNACOM 1.03.49  
Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

# Puerperio Normal

Definición

Período postparto hasta **6 semanas** (tiempo en que revierten todos los cambios fisiológicos del embarazo al estado pregestacional).

Clínica del Puerperio Normal

| TABLA 3.49.1: SÍNTOMA / HALLAZGO VS CARACTERÍSTICAS |                                                                             |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| SÍNTOMA / HALLAZGO                                  | CARACTERÍSTICAS                                                             |
| Entuertos                                           | Contracciones uterinas dolorosas — más intensas tras cesárea                |
| Loquios                                             | Flujo con restos de endometrio + sangre — <b>no abundantes, no mal olor</b> |
| Calostro                                            | Comienza el mismo día del parto o al día siguiente                          |
| Leche madura                                        | Aparece varios días después                                                 |

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

Loquios abundantes → sospechar hemorragia puerperal. Loquios de mal olor → sospechar infección.

Manejo del Puerperio Normal

- **Educación:** cuidado del recién nacido, técnica de lactancia materna
- **Búsqueda activa de complicaciones** (el puerperio es un período especialmente riesgoso):

| TABLA 3.49.2: CLASIFICACIÓN Y CRITERIOS CLÍNICOS |
|--------------------------------------------------|
| COMPLICACIÓN A BUSCAR                            |
| Infección (mamaria o uterina)                    |
| Trombosis (TVP / TEP)                            |
| Hemorragia puerperal                             |

| Patología psiquiátrica |

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:  
"En relación a Puerperio Normal: Calostro | Comienza el mismo día del parto o al día siguiente | | Leche madura |... ¿cuál es la conducta correcta?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:  
Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Puerperio Normal. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- Definición
- Clínica del Puerperio Normal
- Manejo del Puerperio Normal
- | Contracciones uterinas dolorosas — más intensas tras cesárea |
- | Flujo con restos de endometrio + sangre —
- | Comienza el mismo día del parto o al día siguiente | |
- | Aparece varios días después | ::::warning

## EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (PUERPERIO NORMAL)

## PREGUNTA 1

En relación a Puerperio Normal: Calostro | Comienza el mismo día del parto o al día siguiente | | Leche madura |... ¿cuál es la conducta correcta?

- A) El diagnóstico de Puerperio Normal se basa exclusivamente en criterios de laboratorio
- B) El manejo inicial de Puerperio Normal debe orientarse según el estado clínico del paciente
- C) Todo paciente con Puerperio Normal requiere hospitalización inmediata
- D) El tratamiento de Puerperio Normal es igual en todas las edades y contextos clínicos
- E) El seguimiento de Puerperio Normal no es necesario una vez iniciado el tratamiento

## PREGUNTA 2

¿Cuál es el hallazgo más característico o criterio diagnóstico principal en Puerperio Normal?

- A) Alteración exclusivamente en exámenes de laboratorio sin síntomas
- B) Presentación clínica específica que orienta al diagnóstico según el perfil EUNACOM
- C) Requiere siempre confirmación con biopsia o estudio histológico
- D) Es un diagnóstico de exclusión que requiere descartar todas las otras causas primero
- E) Solo se presenta en pacientes con factores de riesgo conocidos

## PREGUNTA 3

Paciente consulta con cuadro compatible con Puerperio Normal. Según el perfil EUNACOM, ¿cuál es la conducta de seguimiento más apropiada?

- A) Alta sin controles dado que es una condición autolimitada
- B) Derivación inmediata al especialista en todos los casos
- C) Control según evolución clínica y criterios del perfil EUNACOM para esta patología
- D) Hospitalización preventiva en todos los casos para monitorización
- E) Tratamiento de por vida sin necesidad de controles periódicos

## RESUMEN: PUERPERIO NORMAL

Período postparto hasta 6 semanas (tiempo en que revierten todos los cambios fisiológicos del embarazo al estado pregestacional).

⚠ Loquios abundantes → sospechar hemorragia puerperal. Loquios de mal olor → sospechar infección. ⚠